



SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

CẨM NANG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

NGƯỜI CAO TUỔI

(Tái bản lần thứ nhất)



Lào Cai, năm 2023

DANH MỤC VIẾT TẮT

DS-KHHGD	Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
CSSK	Chăm sóc sức khỏe
NCT	Người cao tuổi
THA	Bệnh Tăng huyết áp
COPD	Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
ĐTĐ	Đái tháo đường
SSTT	Sa sút trí tuệ
CLB	Câu lạc bộ

SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

CẨM NANG
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

Lào Cai, năm 2023

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về người cao tuổi và một số kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Để người cao tuổi tìm hiểu thông tin và tự chăm sóc bản thân tại nhà.

Cuốn sách gồm 3 phần chính:

- Phần I: Thông tin chung.
- Phần II: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng tránh một số bệnh không lây nhiễm.
- Phần III: Một số bài tập phục hồi chức năng cho người cao tuổi.

Chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu này sẽ giúp ích cho người cao tuổi tham khảo để vận dụng trong cuộc sống và là tuyên truyền viên tích cực cho người cao tuổi tại cộng đồng./.

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGD TỈNH LÀO CAI

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi



Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mường Khương truyền thông cho người cao tuổi xã Nấm Lư



Cán bộ Y tế xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG

1. Các khái niệm về người cao tuổi

Trong những năm gần đây, nhà nước thường sử dụng khái niệm “người cao tuổi” thay cho người già.

Theo quan điểm y học: Người cao tuổi là người ở giai đoạn già hóa gắn liền với việc suy giảm các chức năng của cơ thể.

Theo Luật: Tại điều 2 Luật Người cao tuổi Số 39/2009/QH12 quy định:

“Công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”.

2. Phân loại theo mức độ già hoá

- Nhóm rất già: Từ 80 tuổi trở lên.
- Nhóm trung bình: Từ 70 - 79 tuổi.
- Nhóm còn năng động: Từ 60 - 69 tuổi.

Trong 3 nhóm tuổi, nhóm rất già đáng lưu ý vì ở nhóm tuổi này, nhìn chung sức khoẻ yếu nhiều, cần sự hỗ trợ gia đình và cộng đồng.

3. Nghĩa vụ và vai trò của người cao tuổi

Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người cao tuổi ở Việt Nam là lớp người có vai trò, vị trí quan trọng đối với gia đình và xã hội, đã có những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

- Đối với gia đình, người cao tuổi có vai trò rất lớn trong việc hình thành những giá trị văn hoá gia đình, trong việc chọn lọc những giá trị văn hoá tốt đẹp và là người truyền lại những giá trị văn hoá tốt đẹp ấy cho các thế hệ sau.

- Đối với xã hội, người cao tuổi có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.

4. Nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi

Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi người cao tuổi chết.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi phải cùng nhau hợp tác trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.

PHẦN II

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI; PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

Cùng với quá trình lão hóa, mỗi hệ cơ quan trong cơ thể đều trải qua những sự thay đổi khác nhau. Những biến đổi này là kết quả của sự tương tác giữa môi trường sống, bệnh tật, di truyền, stress và rất nhiều yếu tố khác. Những thay đổi này đôi lúc rất dễ nhận thấy như tóc bạc, da nhăn, lưng gù. Tuy nhiên, có rất nhiều biến đổi âm thầm trong cơ thể mà mắt thường không thể nhận ra được. Những thay đổi này sẽ không bộc lộ cho đến khi người cao tuổi được khám và xét nghiệm. Quá trình lão hóa làm giảm hiệu lực của các cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể, giảm khả năng thích nghi, bù trừ do đó không đáp ứng được những đòi hỏi của sự sống.

Những thay đổi sinh lý do tuổi đôi khi được coi là không thể tránh khỏi và không thể thay đổi. Những thay đổi theo tuổi rất đa dạng, khác nhau giữa các cá thể và các cơ quan bộ phận trong cùng một cá thể. Ví dụ: có người da nhăn nheo và tóc bạc nhưng cũng có

nhiều người khác da căng mịn, tóc đen, có người lưng còng nhưng có người vẫn giữ nguyên vóc dáng như hồi còn trẻ. Sự lão hóa của mỗi cá thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố có thể thay đổi và phòng ngừa được. Sự già hóa sinh học bắt đầu từ giai đoạn trung niên và sau đó sụt giảm một cách tuyến tính theo lứa tuổi cho tới lúc già đời. Đặc tính chung nhất của sự lão hóa là không đồng tốc, không đồng thì. Phân biệt giữa thay đổi sinh lý hay bệnh lý của tuổi già là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

1. Cách phòng tránh ngã ở người cao tuổi

1.1. Phòng ngủ

- Lắp đặt hệ thống đèn thuận tiện giữa phòng ngủ và phòng tắm.
- Đặt đèn, điện thoại, hoặc đèn pin gần giường của người cao tuổi.
- Đặt giường ngủ ở vị trí dễ dàng vào và ra khỏi giường.
- Sắp xếp quần áo trong tủ của người bệnh để dễ dàng khi sử dụng.
- Sắp xếp sàn phòng ngủ gọn gàng.

1.2. Xung quanh khu vực sinh hoạt

- Sắp xếp đồ đạc gọn gàng giữa các lối đi giữa các phòng và hành lang.
- Sắp đặt các đồ dùng trong nhà (bàn, ghế, giường... ở vị trí thấp, vừa tầm với).
- Lắp các hệ thống ánh sáng dễ dàng vào phòng, tránh phải bước vào phòng tối để bật đèn. Hướng dẫn người cao tuổi chỉ đi lại khi trong phòng, cầu thang và hành lang được thấp sáng tốt.
- Không ngồi trên ghế hoặc trên ghế sofa quá thấp nên khó đứng lên, sử dụng ghế có tay vịn.
- Sử dụng thảm chống trượt.

1.3. Phòng bếp

- Không sử dụng thảm.
- Làm sạch ngay lập tức bất kỳ chất lỏng, dầu mỡ, hoặc thức ăn rơi trên sàn nhà.

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

- Đặt những vật dụng trong nhà bếp (dụng cụ nấu, đồ lưu trữ thức ăn...) dễ dàng tiếp cận.
- Không đứng trên ghế hoặc hộp, thang để lấy đồ ở tủ phía trên.

1.4. Cầu thang

- Giữ các bậc thang luôn gọn gàng.
- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đủ sáng, thuận tiện (công tắc đèn phải nằm ở phía trên và dưới của cầu thang). Hoặc xem xét cài đặt hệ thống đèn cảm ứng.
- Để đèn pin gần cầu thang trong trường hợp bị mất điện đột ngột.
- Lắp đặt hệ thống thảm phù hợp, đặt các miếng chống trơn vào từng bậc thang.
- Lắp tay vịn ở cả hai bên cầu thang và sửa chữa ngay các bậc cầu thang bị hỏng.

1.5. Phòng tắm

- Luôn để ánh sáng nhẹ trong phòng tắm và giữ phòng tắm khô ráo.
- Đặt thảm chống trượt cạnh bồn tắm và lối ra vào
- Lắp đặt các thanh vịn trên tường phòng tắm.
- Sử dụng vách ngăn nhà tắm bằng vật liệu không vỡ
- Sử dụng ghế nâng chỗ vệ sinh hoặc lắp đặt tay vịn.
- Sử dụng dép chống trơn trượt trong phòng tắm.

2. Bệnh Tăng huyết áp (THA) là gì?

Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu $\geq 140\text{mmHg}$ và/hoặc huyết áp tâm trương $\geq 90\text{mmHg}$.

2.1. Vai trò của dinh dưỡng trong điều trị THA

Làm hạn chế tăng huyết áp, duy trì được huyết áp mục tiêu và giúp làm ổn định huyết áp (ở NCT huyết áp mục tiêu cần đạt là $< 130/80\text{ mmHg}$).

Giảm tối đa nguy cơ và biến chứng do tăng huyết áp gây ra như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy thận...

2.2. Nguyên tắc Dinh Dưỡng

Kiểm soát và duy trì cân nặng phù hợp: Ở người tăng cân quá mức hoặc béo phì nếu dùng chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp luyện tập giảm cân nặng thì huyết áp cũng giảm. Vì vậy người thừa cân (BMI > 25) và béo phì (BMI > 30) nên được khuyến khích giảm cân vì giảm cân là một yếu tố hạ huyết áp rất có hiệu quả.



2.3. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng

- **Năng lượng:** 30 Kcal/kg cân nặng/ngày đối với người bình thường.

Đối với người thừa cân và béo phì cần giảm bớt để kiểm soát và duy trì cân cân nặng phù hợp.

- **Chất béo:** Chất béo bão hòa (thường có nguồn gốc động vật có nhiều trong thịt đỏ, sản phẩm chế biến sẵn, bơ...) làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, thừa cân béo phì... Vì vậy, người mắc tăng huyết áp nên hạn chế sử dụng các chất béo động vật để giảm nguy cơ các bệnh lý tim mạch. Nên ăn ít mỡ, bơ thay thế bằng dầu thực vật như dầu mè, dầu hướng dương hay dầu cá, lạc,... Hạn chế sử dụng các loại bơ hoặc nước xốt mayonise thay bằng sử dụng các loại gia vị ít béo hoặc không có chất béo. Đặc biệt không nên ăn các loại thực phẩm giàu Cholesterol như óc, lòng, tim gan, phủ tạng,...

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi



- **Đường bột (Glucid):** Các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng chứa nhiều chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu từ đó giúp phòng nguy cơ tăng huyết áp. Hạn chế đường tinh, bánh kẹo ngọt.



- **Đạm (protein):** Sử dụng đạm từ các nguồn thực vật như đậu đỗ, nên ăn các loại thịt nạc, ít béo. Nên ăn các loại đạm giàu chất béo có lợi cho cơ thể “các loại cá có mỡ” 3-5 lần/tuần.



- Hạn chế muối

Với người bệnh tăng huyết áp nên giảm lượng muối dưới 5g/ngày, giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý do tăng huyết áp gây ra.

- Hạn chế muối bằng cách:

Hạn chế nêm nếm mì chính, bột ngọt khi nấu ăn. Hạn chế chấm các loại gia vị trên bàn ăn. Giảm tiêu thụ các thức ăn nhiều muối như dưa muối cà muối, thịt muối, giò chả, pate, mỳ tôm,...

	Thìa nước mắm 10ml Nước mắm 5g có 0,8g muối
	Thìa bột canh 3g Bột canh 5g có 3,8g muối
	Thìa bột nêm 3g Hạt nêm 5g có 3,6g muối



Tăng rau xanh và quả chín trong các bữa ăn

Trái cây và rau quả: Là nguồn cung cấp kali tự nhiên đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm huyết áp. Cần tăng cường bổ sung rau vào bữa trưa và bữa tối. Tập thói quen ăn rau cả vào bữa sáng, sử dụng thêm trái cây vào bữa ăn phụ. Ưu tiên ăn quả chín dạng miếng, múi hơn là xay, ép, vắt nước. Lựa chọn trái cây có lượng đường thấp. Nên tiêu thụ khoảng 300g rau/ngày và 300g quả chín/ngày.



- **Các loại hạt:** Các loại hạt không ướp muối là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa tuyệt vời, chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cho giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Khuyến khích ăn các loại hạt vài lần/tuần.



- **Sữa ít béo:** Canxi không chỉ quan trọng đối với xương mà còn giúp điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, trong khi các loại thực phẩm từ sữa rất giàu canxi, như sữa toàn phần lại chứa nhiều chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe tim mạch. Vì vậy nên sử dụng các sữa tách, ít béo để đem lại sức khỏe cho xương và tim mạch.

- **Đồ uống:** Hạn chế uống các loại đồ uống có cồn, bia, rượu,... cà phê, chè đặc. Nam giới nên hạn chế uống rượu ở mức hai ly hoặc ít hơn mỗi ngày và phụ nữ không nên uống nhiều hơn một ly mỗi ngày. Giảm tiêu thụ rượu, bia có thể làm giảm huyết áp.

2.4. Tăng cường vận động thể lực



Hoạt động thể chất là quan trọng đặc biệt với NCT. Nó giúp duy trì khối cơ của cơ thể, giúp điều hòa huyết áp. Tập thể dục thường xuyên - mục tiêu ít nhất 60 phút mỗi ngày hoặc hầu hết các ngày hoặc 150 phút mỗi tuần.

3. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là gì?

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là một bệnh viêm mãn tính ở phổi gây hạn chế trao đổi khí ở phổi. Các triệu chứng bao gồm khó thở, ho, tăng tiết nhiều chất nhầy (đờm) và thở khò khè ngoài ra bệnh nhân có thể mất khối cơ, suy dinh dưỡng. Bệnh thường do tiếp xúc lâu dài với khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm.

Những người bị COPD có nguy cơ suy dinh dưỡng, phát triển bệnh tim, ung thư phổi.

3.1. Các yếu tố nguy cơ COPD là gì?

- **Tiếp xúc với khói thuốc lá:** Yếu tố nguy cơ đáng kể nhất của COPD là hút thuốc lá trong thời gian dài. Người càng hút nhiều năm và số lượng càng nhiều thì nguy cơ của bệnh càng lớn. Những người tiếp xúc với lượng lớn khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc COPD.

- **Người có tiền sử hen:** Hen là một bệnh viêm đường thở mãn tính, có thể là một yếu tố nguy cơ phát triển COPD. Sự kết hợp giữa hen suyễn và hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc COPD nhiều hơn.

- **Nghề nghiệp tiếp xúc với khói bụi và hóa chất:** Một số công việc cần tiếp xúc lâu dài với khói, hóa chất và bụi có thể gây kích ứng và viêm phổi.

- **Tiếp xúc với khói do đốt cháy nhiên liệu.** Ở các nước đang phát triển, những người tiếp xúc với khói từ việc đốt nhiên liệu để nấu ăn và sưởi ấm trong khi thông khí kém có nguy cơ mắc COPD cao hơn.

- **Do yếu tố di truyền:** Ít gặp, thường là do thiếu alpha-1-antitrypsin là nguyên nhân của một số trường hợp COPD.

3.2. Vai trò của dinh dưỡng trong COPD

Thức ăn là nhiên liệu mà cơ thể cần để thực hiện mọi hoạt động hàng ngày, bao gồm cả việc thở. Cơ thể cần sử dụng thức ăn để cung cấp năng lượng như một phần của quá trình gọi là trao đổi chất. Trong quá trình trao đổi chất, thức ăn và oxy được biến đổi thành năng lượng và CO₂. CO₂ là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của cơ thể và được đào thải ra ngoài cơ thể bằng cách thở ra. Nếu có quá nhiều CO₂ trong cơ thể, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Bệnh nhân mắc COPD thường có biểu hiện khó thở, thở nhanh nên cần nhiều năng lượng hơn so những người không mắc COPD.

Vì vậy cần cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD giúp tránh tình trạng mất cơ, suy dinh dưỡng, tăng sức đề kháng giảm nguy cơ nhiễm trùng từ đó giúp giảm tần suất tái nhập viện ở bệnh nhân COPD.

3.3. Lời khuyên dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD

- Cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng: Cung cấp đủ năng lượng và protein giúp phòng ngừa sụt cân và phòng ngừa tiếp tục mất khối. Có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đường miệng để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho bệnh nhân COPD.

- Chia thành nhiều bữa trong ngày (5-6 bữa/ ngày)

- Thực phẩm nên chế biến mềm, ninh nhừ, cắt nhỏ phù hợp với khả năng nhai nuốt

- Tăng cường lượng đạm từ thịt, cá, trứng, sữa để phòng ngừa mất khối cơ, sụt cân

- Tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu Omega-3 giúp chống viêm và có những hiệu quả nhất định với bệnh nhân COPD. Các thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, dầu đậu nành, dầu oliu, dầu hạt cải....



- Tăng cường lượng Vitamin C từ hoa quả để tăng sức đề kháng, chống oxy hóa.

- Đảm bảo cung cấp đủ canxi và Vitamin D: Canxi có vai trò trong điều hòa hoạt động của cơ, trong đó có cơ hô hấp và hoạt động của xương. Vì vậy cần cung cấp đủ nhu cầu canxi và vitamin D bằng cách cung cấp các thực phẩm từ sữa (sữa, pho mát, sữa chua...) hoặc bổ sung các sản phẩm chứa Canxi và vitamin D.



- Nên chia nhỏ bữa ăn để tránh ăn quá no gây đầy hơi hoặc chướng bụng.

Đầy bụng hoặc chướng bụng có thể gây khó thở. Tránh các thức ăn gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Một số thực phẩm gây đầy hơi cho một số người bao gồm đồ uống có ga, thực phẩm chiên, nhiều dầu mỡ hoặc nhiều gia vị, bắp cải, súp lơ...

3.4. Nếu trong giai đoạn đợt cấp, khó thở nhiều nên

- Ưu tiên sử dụng các loại sữa cao năng lượng cho người bệnh.
- Chọn thức ăn mềm, ninh nhừ, dễ nhai, nuốt.
- Ăn chậm, cắn từng miếng nhỏ và nhai thức ăn từ từ.
- Chia nhỏ bữa ăn để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng trong ngày và giảm khó thở khi ăn một bữa lớn.
- Hạn chế uống nước trước hoặc trong bữa ăn do làm tăng cảm no hoặc chướng bụng.

Cần chú ý phòng ngừa hiện tượng sặc trong khi ăn thì cần phối hợp nhịp nhàng giữa thực hiện động tác thở với nhịp nuốt và tư thế ngồi ăn hợp lý.

4. Bệnh Đái tháo đường là gì?

Đái tháo đường là tình trạng lượng đường trong máu luôn cao hơn mức bình thường do cơ thể bị thiếu hụt hoặc đề kháng với insulin, dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Glucose máu cao gây ra các biến chứng không có lợi cho sức khỏe. Theo thống kê trong năm 2015, trên toàn thế giới có 415 triệu người trưởng thành (độ tuổi 20-79) mắc ĐTD tức là cứ 11 người trưởng thành thì lại có 1 người mắc ĐTD.

4.1. Đái tháo đường gây ra những biến chứng gì?

Đái tháo đường gây tổn thương, rối loạn, suy giảm nhiều cơ quan. Người mắc ĐTD có nguy cơ mắc các bệnh lý do tổn thương mạch máu, hệ thần kinh như xuất huyết não, nhồi máu cơ tim, giảm thị lực, suy thận, viêm dây thần kinh, các vết loét lâu liền đặc biệt ở bàn chân....

4.2. Ai là người có nguy cơ mắc ĐTD?

- Tuổi: Thường xuất hiện ở người trên 40 tuổi, cũng có thể ở người trẻ hơn.

- Gia đình: Người có bố, mẹ hoặc anh chị em bị đái tháo đường có nguy cơ mắc cao hơn.

- Béo phì, ít hoạt động thể lực.

- Tiền sử: Đái tháo đường thai kỳ trước đó.

4.3. Dinh dưỡng là cần thiết trong điều trị ĐTD?

Bản chất của đái tháo đường là hạ tăng đường huyết ngay sau ăn và hạ sâu đường huyết khi ở xa bữa ăn. Ngoài việc dùng thuốc, hoạt động thể lực thì chế độ ăn trong điều trị bệnh đái tháo đường cũng đóng vai trò rất quan trọng. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp kiểm soát đường huyết tốt, chậm tiến triển bệnh, giảm nguy cơ mắc biến chứng do ĐTD gây ra.

4.4. Nguyên tắc dinh dưỡng trong đái tháo đường

- Cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng.

- Ăn đúng giờ đúng bữa để làm giảm tình trạng rối loạn đường huyết.

- Chia thành nhiều bữa trong ngày(5-6 bữa/ ngày) không để đói quá, không để no quá.

- Tăng cường lượng rau xanh trong các bữa ăn.

4.5. Thế nào là một chế độ dinh dưỡng hợp lý?

- Duy trì cân nặng lý tưởng: Với người mắc ĐTD kiểm soát cân nặng giúp kiểm soát đường huyết. Hạn chế tình trạng thừa cân, béo phì hoặc suy dinh dưỡng.

- Cung cấp đủ và cân đối các nhóm chất dinh dưỡng: Với NCT

mắc ĐTĐ thì việc cung cấp đủ năng lượng và cân đối các chất dinh dưỡng là quan trọng. Nhiều nghiên cứu lại cho rằng với NCT không cần cắt giảm quá nhiều lượng chất bột đường mà quan trọng là cần phải lựa chọn các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp.

- Chỉ số đường huyết của thực phẩm: Khả năng làm tăng đường huyết sau khi ăn được gọi là chỉ số đường huyết của loại thức ăn đó. Các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp làm tăng đường máu từ từ và đường máu sẽ thấp sau khi ăn. Các thực phẩm với chỉ số đường huyết cao làm đường máu tăng nhanh và tăng cao sau khi ăn.

- Các loại thực phẩm như: Bánh mì trắng, khoai lang nướng, gạo xay sát kỹ, bánh kẹo ngọt, hoa quả sấy khô... đều được cho là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, người mắc ĐTĐ cần hạn chế.



Bánh mì trắng



Khoai lang

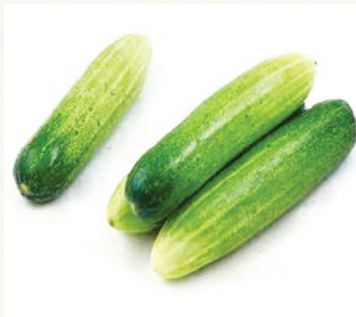
- Gạo giã dối, yến mạch, bánh mì đen và ngũ cốc hay các loại quả như bưởi, roi, dưa chuột, củ đậu... là nguồn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp người mắc ĐTĐ nên sử dụng.



Gạo lứt



Khoai lang luộc



Dưa chuột



Ổi

- Hạn chế các chất béo từ da động vật, mỡ động vật, phủ tạng động vật... Thay vào đó nên sử dụng các loại chất béo từ dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu oliu... Mỗi tuần nên ăn 2-3 bữa cá.

- Tăng cường chất xơ: Chất xơ trong dạ dày kéo dài thời lưu trữ thức ăn, giảm việc tăng nhanh đường máu sau ăn. Các loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao gồm: súp lơ xanh, bông cải, rau ngót, giá đỗ, các loại rau họ cải, các loại ngũ cốc nguyên cám... Với người bệnh ĐTD nên ăn rau trước sau đó mới ăn cơm và thức ăn, giúp làm chậm đường huyết sau ăn.

- Tránh bỏ bữa. Cần ăn 2-3 bữa phụ trong ngày để tránh tình trạng ăn quá nhiều vào bữa chính gây tăng đường huyết sau ăn. Bỏ bữa có thể khiến hạ đường huyết, giảm khả năng tập trung.

- Cắt giảm muối: Tiêu thụ giảm muối giúp giảm nguy cơ mắc tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch ở người mắc ĐTD. Tiêu thụ muối dưới 5 g/ngày. Hạn chế sử dụng các thực phẩm nhiều muối như: sản phẩm chế biến sẵn, cá khô, dưa muối, cà muối, mỳ tôm...

- Hạn chế tiêu thụ rượu, bia. Hạn chế tiêu thụ rượu, bia. Rượu bia có thể ức chế tân tạo đường do đó dễ làm hạ đường huyết, nhất là khi không ăn. Nếu tiêu thụ, khẩu phần hàng ngày cần hạn chế 1 đơn vị đối với nữ, 2 đơn vị đối với nam. Một đơn vị định nghĩa 350ml bia, 150ml rượu vang, 50ml rượu mạnh.

- Nên tập thể dục 30-40 phút mỗi mỗi ngày, tập luyện thường xuyên với cường độ hợp lý. Áp dụng các bài tập nhẹ nhàng như đạp xe, đi bộ, tập dưỡng sinh.....

5. Sa sút trí tuệ (SSTT)

Là một hội chứng biểu hiện bằng sự suy giảm nhận thức, gây cản trở hoạt động chức năng hàng ngày của người mắc. SSTT ngày càng tăng nhanh, rất thường gặp ở người cao tuổi và SSTT làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Bệnh sa sút trí tuệ là bệnh ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh (hạn chế vận động, giảm và mất nhận thức...). Do đó, điều quan trọng trong chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ là tư vấn và hướng dẫn cho người chăm sóc.

5.1. Dinh dưỡng hợp lý là điều quan trọng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Đối với một người bị bệnh sa sút trí tuệ, dinh dưỡng kém có thể làm nặng thêm các triệu chứng rối loạn hành vi và gây giảm cân. Giảm cân làm tăng nguy cơ mắc bệnh, ngã, loét tỳ đè và tử vong ở các bệnh nhân sa sút trí tuệ. Cần cung cấp kiến thức về dinh dưỡng cho người chăm sóc bệnh sa sút trí tuệ phòng giảm cân và suy dinh dưỡng. Sa sút trí tuệ không cần một chế độ ăn nào chuyên biệt mà việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng là rất quan trọng.

5.2. Các lời khuyên dinh dưỡng cho người mắc Sa sút trí tuệ

- Cung cấp chế độ dinh dưỡng đủ năng lượng, đa dạng các loại thực phẩm giúp tăng khẩu phần ăn vào và phòng ngừa giảm cân, suy dinh dưỡng ở người bệnh SSTT.



Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

- Cân đối protein động vật và thực vật giúp cân đối hàm lượng acid amin và tăng hiệu quả hấp thu chất đạm. Hạn chế thức ăn có nhiều chất béo bão hòa và cholesterol như thịt mỡ, nội tạng, óc động vật, trứng vịt lộn....

- Hạn chế thức ăn có nhiều natri và dùng ít muối, phòng ngừa các bệnh tim mạch: Tăng huyết áp, tai biến, đột quỵ, cũng như phòng ngừa tiến triển SSTT sau các đợt tai biến hoặc đột quỵ.



- Người sa sút trí tuệ thường không thể cung cấp đủ năng lượng, các chất dinh dưỡng trong các bữa chính. Vì vậy nên chia ra thành bữa ăn nhỏ hơn và thường xuyên hơn phù hợp sở thích của người bệnh. Lưu ý cũng nên lựa chọn các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cao năng lượng như sữa bột, sữa chua hoặc các loại sinh tố có thêm sữa đặc....

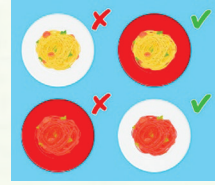
- Người SSTT có thể quên bữa ăn, nên việc giám sát bữa ăn, ăn đúng giờ để đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng cho người bệnh.



- Thường xuyên cung cấp đủ nước vì người mắc SSTT thường quên uống nước, đôi khi họ gặp phải các vấn đề về rối loạn nuốt nên họ sợ uống nước. Có thể cần phải bổ sung các chất tạo đặc vào nước để cung cấp đủ nước cho cơ thể nhưng cần phải được đánh giá rối loạn nuốt từ chuyên gia để hướng dẫn sử dụng phù hợp với tình trạng bệnh lý.

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

- Sử dụng bát, đĩa nhỏ để có thể dễ sử dụng. Chú ý tới độ tương phản màu sắc của bát, đĩa và thức ăn để người bệnh có thể dễ dàng phân biệt thức ăn hơn.



- Chế biến món ăn phù hợp với khả năng nhai nuốt của người mắc SSTT. Đôi khi phải cắt nhỏ thức ăn để dễ nhai hơn. Thử các loại thực phẩm mềm hơn nếu có vấn đề về nhai.



- Kiểm tra nhiệt độ thực phẩm. Một người bị sa sút trí tuệ có thể không phân biệt được nếu ăn hoặc uống thứ gì đó quá nóng. Luôn kiểm tra nhiệt độ của thực phẩm và đồ uống trước khi cho người bệnh ăn.

- Tạo bầu không khí thân thiện, vui vẻ trong bữa ăn. Người SSTT thường ăn rất chậm vì vậy việc cho họ ăn có thể là gánh nặng với người chăm sóc. Người chăm sóc nên làm mẫu cho họ. Tránh sao nhãng bữa ăn bằng cách hạn chế sử dụng TV và đài trong bữa ăn, hạn chế để những đồ dùng không cần thiết trong bữa ăn.



- Khi bệnh tiến triển, chán ăn và sụt cân là vấn đề phổ biến. Trong những trường hợp như vậy, cần có sự tư vấn của bác sĩ và các chuyên gia về dinh dưỡng để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho người bệnh.

PHẦN III

MỘT SỐ BÀI TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI

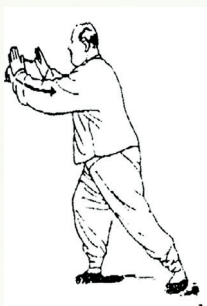
1. Luyện tập sức bền

Các bài tập sức bền là bài tập có sự tham gia của nhiều nhóm cơ trong một khoảng thời gian tối thiểu 10 phút.

Các hoạt động như đi bộ, chạy, khiêu vũ, đạp xe, bơi, thái cực quyền... được xếp vào nhóm bài tập sức bền.

Nếu luyện tập sức bền đều đặn và đủ thời gian thì có hiệu quả tốt đến cơ quan tim mạch, hô hấp như giảm huyết áp, giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như giúp kiểm soát bệnh mạn tính như tim mạch, rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường, béo phì, thừa cân rối loạn chuyển hóa lipid, các bài tập sức bền còn có hiệu quả đối với loãng xương, giảm trầm cảm, nguy cơ mắc ung thư (ung thư đại tràng) cải thiện chức năng nhận thức đối với suy giảm nhận thức nhẹ.

Cách tập luyện sức bền như thế nào khi người cao tuổi phải cách ly để tránh tiếp xúc với nguy cơ ngoài cộng đồng. Nhân viên y tế có thể hướng dẫn người cao tuổi lựa chọn các bài tập theo sở thích như bước tại chỗ, bước tiến bước lùi theo hình chữ V, đạp xe tại chỗ, tập thái cực quyền, đi bộ vòng quanh sân, hành lang nhà vì đối với các bài tập này không cần quá nhiều không gian và diện tích để tập luyện.



2. Luyện tập tăng cường sức mạnh cơ

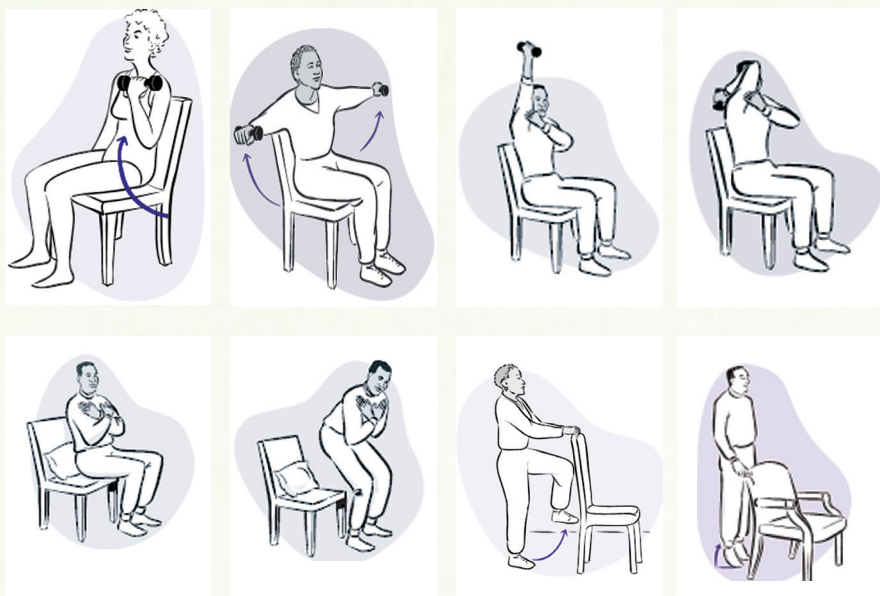
Sức mạnh cơ thể hiện bằng các hoạt động hàng ngày như khả năng đứng lên ngồi xuống, lên xuống cầu thang, bê/xách đồ hay nâng đẩy đồ đạc khi thu dọn nhà cửa. Sức mạnh cơ giảm dần theo tuổi do khối lượng cơ bắp giảm dần tới teo cơ và yếu cơ. Yếu cơ sẽ càng giảm nhanh nếu như người cao tuổi giảm vận động (ngồi đọc báo, xem vô tuyến hay chỉ chơi cờ hoặc ngồi nói chuyện khi uống trà hoặc nằm nhiều). Giai đoạn ở nhà phòng dịch COVID-19, người cao tuổi dễ bị rơi vào tình trạng giảm vận động, cơ sẽ yếu và teo nhanh hơn nếu như không được tập luyện, các bệnh mạn tính như tiểu đường khó kiểm soát hơn, cân nặng dễ tăng hơn làm đau nhức khớp xương do quá tải về cân nặng. Do vậy, việc hướng dẫn các cụ tập luyện tăng cường sức mạnh cơ là rất quan trọng để phòng tránh yếu teo cơ, duy trì chức năng hàng ngày, giúp kiểm soát các bệnh mạn tính như tiểu đường, thừa cân, béo phì, thoái hóa khớp, loãng xương.

Tập tăng cường sức mạnh cần nhắm vào một số nhóm cơ chính ở chi trên và chi dưới để đảm bảo chức năng sinh hoạt hàng ngày như đi lại, đứng dậy nâng xách đồ, phòng tránh ngã, giảm đau trong thoái hóa khớp gối.

Các dụng cụ tập có thể mua như tạ, dây đàn hồi hoặc tự làm tại nhà bằng chai/lọ nước, cát/thóc/ngô.



Tạ tay 0,5-3 kg



Tập tăng cường sức mạnh cơ

Cách tập:

Lựa chọn khối lượng tạ vừa theo sức của mình. Nâng tạ theo các động tác gập khuỷu/dưới khuỷu tay hoặc dang tay từ 7 - 15 lần/hiệp, mỗi động tác tập 3 hiệp, tập luân phiên các động tác). Cần nghỉ giữa các hiệp tập, rồi lặp lại chuỗi tập.

Tập mạnh các nhóm cơ chi dưới: đứng dậy/ngồi xuống, đứng trên mũi chân, đứng trên gót chân.

Các bài tập tăng cường sức mạnh cơ cần thực hiện 3 buổi/tuần.

3. Bài tập cải thiện thăng bằng

Tập luyện giúp duy trì và cải thiện thăng bằng cho cơ thể. Tuổi càng cao khả năng giữ thăng bằng của cơ thể càng giảm do cơ yếu, mắt kém và chức năng tiền đình suy giảm kèm theo các bệnh đồng mắc làm suy yếu thêm khả năng giữ thăng bằng như đau khớp, tai biến mạch não, Parkinson...

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

Các bài tập thăng bằng giúp phòng tránh ngã, giảm nguy cơ ngã đồng nghĩa giảm chấn thương như gãy xương cho người cao tuổi.



Đi mũi chân chạm gót



Đứng trên 1 chân



Tập thái cực quyền



Kéo dẫn nhóm cơ đùi sau/trước KD cơ cẳng chân sau KD cơ chi trên

Tập thăng bằng

Không tập luyện khi có các triệu chứng sau: Chóng mặt, đau ngực hay khó thở, không tập luyện khi tăng huyết áp chưa kiểm soát được, nhịp tim khi nghỉ trên 120 lần/phút hay dưới 50 lần/phút, khi đang bị nhiễm khuẩn, sốt, đường máu cao chưa kiểm soát được bệnh nhiễm khuẩn kèm có sốt, sưng đau khớp, đang có vấn đề về bệnh vông mạc (bong vông mạc, sau hoặc đang điều trị laser bệnh vông mạc), sau thay thủy tinh thể.

4. Các bài tập phòng tránh ngã trên người cao tuổi

4.1. Lưu ý trước khi tập

- Huấn luyện viên hoặc bản thân người tập (người cao tuổi-NCT) xác nhận tình trạng sức khỏe, đo huyết áp, nhịp tim của người tập.

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

- Trong lúc tập nếu cảm thấy cơ thể không khỏe cần báo ngay với nhân viên.

- Trước và sau khi tập cần uống đủ nước (hoặc trà). Không tập khi đang đói

4.2. Đảm bảo an toàn khi tập

- Thở đều khi tập. Trong lúc tập không được nín thở (nếu nín thở huyết áp sẽ tăng).

- Vừa tập vừa đếm theo động tác là cách tự nhiên để duy trì nhịp thở.

4.3. Tần suất và mức độ tập

- Tập 1 tuần ít nhất 1 lần sẽ có hiệu quả! Chọn ra ít nhất 1 ngày trong tuần hoặc cách mỗi tuần để thực hiện bài tập vận động cơ.

- Lựa chọn phù hợp số thanh của tạ tập khiến người tập cảm thấy thoải mái.

- Đối với các động tác vận động cơ nâng tạ lên trong 4 giây và hạ xuống trong 4 giây. Việc nâng lên và hạ xuống từ từ và duy trì đều tốc độ rất quan trọng

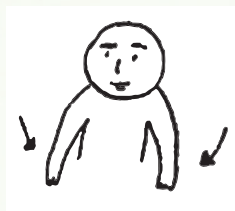
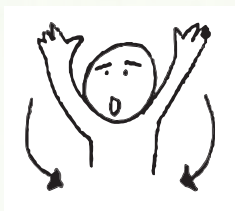
- Sau khi tập sẽ bị đau nhẹ ở cơ hoặc hơi mệt mỗi trong một vài ngày. Tuy nhiên nếu bị mệt mỏi và đau cơ, khớp nhiều thì đó là dấu hiệu của việc tập quá sức.

4.4. Bài tập khởi động

- **Động tác 1:** Trước khi vận động cần hít thở để điều hòa cơ thể.

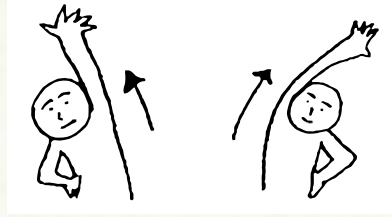
Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.

Hít vào bằng mũi và thở kéo căng lườn.



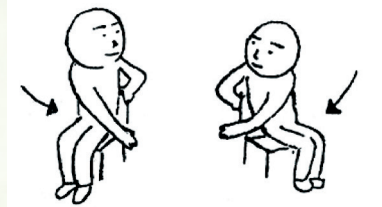
- Động tác 2: Kéo căng vai và
lườn không căng vai

Lần lượt giơ cao tay phải và
trái; làm ấm cơ thể

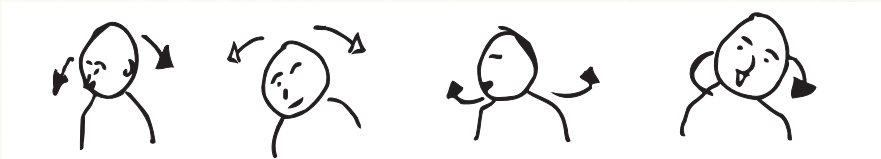


- Động tác 3:

Lần lượt xoay người sang trái,
sang phải



- Động tác 4: Làm ấm vùng cổ
và quanh vai

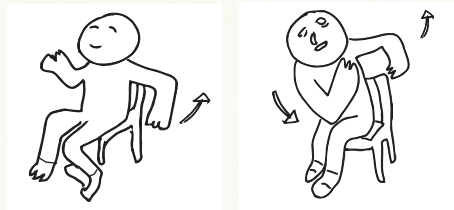


- Gập cổ từ trước ra sau và ngược lại
- Nghiêng đầu từ trái sang phải và ngược lại
- Quay cổ từ trái sang phải và ngược lại
- Xoay cổ 360 độ từ trái qua phải và ngược lại

- Động tác 5. Bước chân

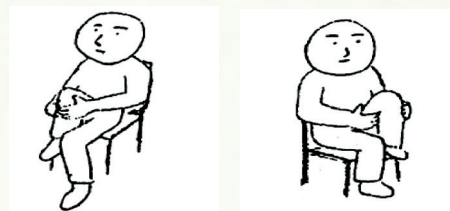
+ *Làm nóng cơ thể*

- Làm động tác vung hai tay
và bước chân



- Động tác 6. Vận động
khớp háng

Kéo dẫn khớp háng, khởi
động chân



Cẩm nang chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi

- Ôm chân và kéo về gần ngực

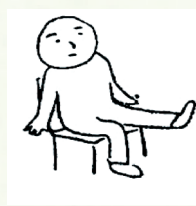
- **Động tác 7.** Kéo căng đầu gối

Làm nóng bắp đùi và đầu gối

Giơ các đầu ngón chân hướng lên trên, kéo căng đầu gối

- **Động tác 8.** Hít thở sâu

Giống động tác 1, hít thở sâu điều hòa cơ thể



BÀI TẬP CƠ

Động tác 1. Nâng tay lên phía trước

- Đây là động tác tăng cường lực cơ cánh tay trước. Phần cơ này có tác dụng khi cầm đồ vật lên.

Tư thế chuẩn bị

Ngồi lên ghế thẳng lưng (không tựa lưng ra sau ghế). Thả lỏng tay tự nhiên ở 2 bên người, 2 chân để trên sàn nhà, tạo tư thế ngồi thoải mái, trong vòng 4 giây nâng tay có tạ tập lên phía trước cao bằng vai (như hình minh họa), sau đó hạ tay xuống trong vòng 4 giây. Nếu bị đau thì chỉ cần nâng tay đến vị trí cảm thấy thoải mái.

Lưu ý: Trong lúc nâng tay lên cao chú ý duỗi thẳng khuỷu tay, bàn ta nắm chặt hình nắm đấm.



Động tác 2. Nâng tay sang ngang duỗi thẳng

Ngồi lên ghế thẳng lưng (không tựa lưng ra sau ghế).

Thả lỏng tay tự nhiên ở 2 bên người. 2 chân để trên sàn nhà, tạo tư thế ngồi thoải mái, trong vòng 4 giây nâng tay có tạ tập sang ngang lên cao (như hình minh họa), sau đó hạ tay xuống trong vòng 4 giây. Nếu bị đau thì chỉ cần nâng tay đến vị trí cảm thấy thoải mái.

Lưu ý: Nâng tay sang ngang sao cho khi nhìn chính diện trong vòng 490 độ.



Động tác 3. Ngồi tựa lưng nhẹ sau ghế. 2 tay khoanh trước ngực - lúc này tay không đeo tạ. Từ từ đứng dậy trong vòng 8 giây (như hình minh họa), sau đó ngồi trở lại ghế trong vòng 8 giây.

Lưu ý: Với những người đau đầu gối hoặc đau lưng thì thay vì khoanh tay trước ngực, có thể hướng người ra phía trước hoặc vịn tay vào bàn và từ từ đứng lên ngồi xuống trong khoảng thời gian và tốc độ bằng nhau.

Động tác 4. Kéo căng đằng ti: Ngồi tựa lưng nhẹ sau ghế, để 2 chân trên sàn nhà, tạo tư thế ngồi thoải mái.

Lưu ý: Lúc nâng chân lên chú ý cho mũi chân hướng lên trần nhà, lúc hạ chân xuống thì từ từ đưa chân về vị trí ban đầu.



Động tác 5. Nâng chân ra phía sau: Đây là động tác tăng cường lực cơ mông sau. Phần cơ này có tác dụng khi đi lại, đứng, hoặc đứng thẳng.

Đứng chống tay sau lưng ghế, cách ghế khoảng 30cm, trong vòng 4 giây nâng chân có tạ tập lên hướng ra phía sau (như hình minh họa), sau đó hạ chân về trong vòng 4 giây

Lưu ý

Khi duỗi chân ra phía sau chú ý không gập đầu gối quá nhiều, đừng để cơ thể đổ ra phía trước quá nhiều.

Bài tuổi chân ra phía sau chú ý

Đây là động tác duỗi chân ra phía sau chú ý không gập đầu quá nhiều, đừng để cơ thể đổ ra phía trước quá nhiều.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Người cao tuổi (số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009).
2. Tài liệu hỏi đáp về chăm sóc sức khỏe sinh sản người cao tuổi (Xuất bản Tổng cục Dân số - KHHGĐ, năm 2011).
3. Tài liệu các nội dung về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (Xuất bản Tổng cục Dân số - KHHGĐ, năm 2020).

MỤC LỤC

NỘI DUNG	Trang
Lời nói đầu	3
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG	5
1. Các khái niệm về người cao tuổi	5
2. Phân loại nhóm tuổi	5
3. Vai trò của người cao tuổi	5
4. Nghĩa vụ và quyền phụ dưỡng người cao tuổi	6
PHẦN II. CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI; PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM	6
1. Cách phòng tránh ngã ở người cao tuổi	7
2. Bệnh Tăng huyết áp (THA) là gì? chế độ dinh dưỡng	8
3. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là gì, yếu tố nguy cơ và chế độ dinh dưỡng	13
4. Bệnh Đái tháo đường là gì? chế độ dinh dưỡng	15
5. Bệnh Sa sút trí tuệ (SSTT); chế độ dinh dưỡng	19
PHẦN III. MỘT SỐ BÀI TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI	22
1. Luyện tập sức bền	23
2. Luyện tập tăng cường sức mạnh cơ	23
3. Bài tập cải thiện thăng bằng	24
4. Các bài tập phòng tránh ngã trên người cao tuổi	25
TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

CKIYTCC, Dược sỹ Đại học. PHẠM HỒNG THANH
Phó Chỉ cục trưởng Chỉ cục Dân số-KHHGD tỉnh Lào Cai

BIÊN SOẠN

CKIYTCC, Dược sỹ Đại học. Phạm Hồng Thanh
CN. Vi Thị Việt Hà
CN. Phạm Thanh Bình

BIÊN TẬP VÀ HIỆU ĐÍNH

CKIYTCC, Dược sỹ Đại học. Phạm Hồng Thanh
Phó Chỉ cục trưởng Chỉ cục Dân số-KHHGD tỉnh Lào Cai
CN. Vi Thị Việt Hà,
Trưởng phòng Truyền thông - Giáo dục
CN. Phạm Thanh Bình,
Chuyên viên phòng Truyền thông - Giáo dục

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGD

Tầng 4 - Khối V - phường Bình Minh - thành phố Lào Cai
ĐT: (02143) 842 820
Email: ccaskhhgd-syt@laocai.gov.vn; Cổng TTĐT: danso.laocai.gov.vn

In tái bản 2.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm, tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Lào Cai, Đ/c: 002 Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143800328
Giấy phép xuất bản tài liệu số 38/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai cấp ngày 19 tháng 5 năm 2023. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2023.

